

PROTOCOLO DE INTERVENCION TCC

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)

Manual del Terapeuta

Basado en los modelos de Borkovec, Wells y Barlow | Evidencia nivel A

1. Descripcion del Trastorno

1.1 Criterios diagnosticos (DSM-5)

Ansiedad y preocupacion excesiva, dificil de controlar, presente la mayoria de los dias durante al menos 6 meses, sobre una amplia variedad de eventos o actividades.

La preocupacion interfiere significativamente en el funcionamiento diario.
La persona reconoce que su nivel de preocupacion es desproporcionado.

Sintomas fisicos (deben estar presentes al menos 3 de los siguientes):

- Inquietud o sensacion de estar con los nervios de punta
- Fatigabilidad facil
- Dificultad para concentrarse o mente en blanco
- Irritabilidad
- Tension muscular
- Problemas de sueno (dificultad para conciliar o mantener el sueno)

1.2 Prevalencia y curso

- Prevalencia de vida: 5,7% en poblacion general
- Mas frecuente en mujeres (relacion 2:1)
- Inicio habitual: juventud o adultez temprana
- Curso cronico con fluctuaciones; exacerbaciones en periodos de estres
- Alta comorbilidad: depresion mayor (60%), otros trastornos de ansiedad

1.3 Diagnostico diferencial

Diagnostico	Diferenciacion clave
Trastorno de panico	En TAG la preocupacion es difusa; en panico el miedo es a las

	crisis en si
Depresion mayor	En TAG la preocupacion precede al estado de animo bajo; evaluar temporalidad
TOC	En TOC los pensamientos son intrusivos y egodistonicos; en TAG son egosintonicos
Ansiedad por salud	En TAG la preocupacion abarca multiples dominios, no solo la salud

2. Modelo Cognitivo del TAG

2.1 Modelo de Borkovec: preocupacion como evitacion

- Las imagenes mentales amenazantes generan mayor activacion fisiologica que las preocupaciones verbales
- La persona preocupada evita procesar emocionalmente el miedo, impidiendo la habituacion
- La preocupacion se mantiene por refuerzo negativo: alivia momentaneamente la tension

2.2 Modelo de Wells: metacogniciones

TIPO 1 - Preocupaciones de primer orden (sobre situaciones externas o internas):
'Y si pierdo el trabajo', 'Y si me enfermo', 'Y si no llego a tiempo'

TIPO 2 - Meta-preocupaciones (preocuparse sobre la preocupacion):
'Preocuparme tanto me va a volver loco', 'No puedo controlar mis preocupaciones'

Creencias positivas sobre la preocupacion (tambien mantienen el ciclo):
'Preocuparme me ayuda a estar preparado', 'Si me preocupo, evito que ocurra lo malo'

2.3 Ciclo de mantenimiento

DISPARADOR -> Preocupacion/Rumiacion -> Activacion fisiologica
-> Conductas de seguridad y evitacion -> Alivio temporal
-> Refuerzo negativo -> REGRESO AL DISPARADOR

3. Estructura del Protocolo

3.1 Duracion y formato

- Sesiones: 12 a 16 sesiones individuales
- Frecuencia: semanal (quincenal en fase de consolidacion)
- Duracion por sesion: 50-60 minutos

3.2 Mapa de sesiones

N	Titulo	Objetivos	Tecnicas principales
1	Evaluacion y psicoeducacion	Establecer alianza, explicar TAG y modelo cognitivo	Entrevista, psicoeducacion, autorregistro
2	Psicoeducacion y metas	Validar experiencia, acordar objetivos	Formulacion de caso, metas colaborativas
3	Identificacion de preocupaciones	Distinguir preocupaciones tipo 1 y tipo 2	Registro de preocupaciones, analisis funcional
4	Reestructuracion cognitiva I	Cuestionar creencias positivas sobre la preocupacion	Cuestionamiento socratico, experimentos
5	Reestructuracion cognitiva II	Cuestionar meta-preocupaciones	Flecha descendente, evidencias pro/contra
6	Relajacion muscular progresiva	Reducir activacion fisiologica cronica	RMP de Jacobson, respiracion diafragmatica
7	Control del estimulo	Delimitar tiempo y espacio de preocupacion	Tiempo de preocupacion, postergacion activa
8	Tolerancia a la incertidumbre	Reducir intolerancia a la incertidumbre	Exposicion conductual, experimentos
9	Resolucion de problemas	Diferenciar preocupacion util e inutil	Tecnica D'Zurilla, plan de accion
10	Exposicion cognitiva	Exposicion al peor escenario imaginado	Exposicion imaginaria, decatastrofizacion
11	Mindfulness de la preocupacion	Observar pensamientos sin fusion cognitiva	Defusion cognitiva, atencion plena
12	Prevencion de recaidas	Revisar logros, plan de mantenimiento	Revision del caso, senales de alerta

4. Tecnicas de Intervencion

4.1 Psicoeducacion

- Normalizar la ansiedad como emocion adaptativa
- Diferenciar ansiedad funcional de disfuncional

- Presentar el modelo cognitivo del TAG en terminos accesibles
- Explicar el rol de la preocupacion como evitacion cognitiva

Metafora recomendada - La alarma de humo sensible:

'La ansiedad es como una alarma de humo. En tu caso, la alarma esta muy sensible: se activa no solo con el fuego real, sino con el vapor de la ducha o el humo del asado. El problema no es la alarma en si — nos protege. El problema es que esta mal calibrada. Nuestro trabajo juntos es recalibrarla.'

4.2 Reestructuracion Cognitiva

Preguntas de cuestionamiento socratico para el TAG:

- Que evidencia tenes de que esto va a pasar?
- Que es lo mas realista que puede ocurrir?
- Cuantas veces te preocupaste por algo similar y no ocurrio?
- Que le dirias a una amiga que pensara esto?
- Preocuparte ahora cambia algo de lo que puede pasar?
- Podas tolerar la incertidumbre de no saber el resultado?

4.3 Relajacion Muscular Progresiva (Jacobson)

- Practicar 2 veces por dia en las primeras 3 semanas
- Ciclos: tensar 7-10 segundos, soltar 20-30 segundos
- Grupos musculares: manos, antebrazos, biceps, hombros, cuello, frente, ojos, mandibula, abdomen, gluteos, piernas, pies
- Progresar de 16 grupos a 8 grupos a 4 grupos conforme avanza el entrenamiento

4.4 Tiempo de Preocupacion (Worry Time)

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE:

1. Elegir un horario fijo de 20-30 minutos por dia (NO antes de dormir).
2. Cuando surja una preocupacion fuera de ese horario, anotarla y posponerla.
3. Durante el tiempo asignado, permitirse preocuparse activamente.
4. Al finalizar el tiempo, cerrar el cuaderno y retomar las actividades.

El objetivo es contener la preocupacion en un espacio delimitado, no eliminarla.

4.5 Exposición a la Incertidumbre

- Construir jerarquía de situaciones que generan incertidumbre (de menor a mayor malestar)
- Exponerse gradualmente sin realizar conductas de seguridad
- Ejemplos: no revisar el mail por 2 horas, no llamar al hijo para saber como llegó
- Registrar nivel de malestar antes y después (0-10) para verificar habituación

4.6 Prevención de Recaídas

- Revisar técnicas aprendidas y cuáles fueron más útiles para el paciente
- Identificar señales de alerta personales
- Elaborar un plan de acción escrito para cuando surjan dificultades
- Normalizar la recaída como parte del proceso, no como fracaso
- Planificar sesiones de seguimiento: al mes, a los 3 meses, a los 6 meses

5. Consideraciones Clínicas

5.1 Obstáculos frecuentes

- Paciente que intelectualiza sin bajar al nivel emocional: usar técnicas experienciales y corporales
- Alta comorbilidad depresiva: evaluar si es prioritario trabajar primero el estado de ánimo
- Resistencia muy alta a la incertidumbre: trabajar tolerancia al malestar antes de la exposición
- Abandono de tareas entre sesiones: explorar obstáculos, simplificar tareas iniciales

5.2 Indicadores de progreso

- Reducción en el GAD-7 (al menos 5 puntos al terminar el protocolo)
- Mayor capacidad de posponer preocupaciones
- Aumento en tolerancia a la incertidumbre
- Disminución de conductas de seguridad
- Mejora en calidad del sueño

6. Referencias Bibliográficas

Borkovec, T. D. y Costello, E. (1993). Efficacy of applied relaxation and cognitive-behavioral therapy in the treatment of GAD. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 61(4), 611-619.

Wells, A. (1997). *Cognitive therapy of anxiety disorders*. Wiley.

Barlow, D. H. (2002). *Anxiety and its disorders* (2nd ed.). Guilford Press.

Clark, D. A. y Beck, A. T. (2010). *Cognitive therapy of anxiety disorders*. Guilford Press.

American Psychiatric Association (2013). *DSM-5*. APA Publishing.